Estratégia CONCURSOS

Aul

SUS e Atenção Básica p/ UFRJ - Fisioterapeuta

Professor: Adriano de Oliveira

AULA 00: LEI ORGÂNICA DA SAÚDE

SUMÁRIO	PÁGINA
1. Apresentação da Aula	2
2. A Lei Orgânica da Saúde	4
3. Determinantes Sociais da Saúde	13
4. Vigilância em Saúde	19
5. Princípios e diretrizes do SUS	30
6. Organização do SUS	43
7. Estrutura de Governança do SUS	59
8. Referências	63
9. Questões de revisão	64
10. Gabarito	82

APRESENTAÇÃO DA AULA

Exploraremos nesta aula a Lei Orgânica da Saúde, a lei que definiu as diretrizes para constituição do Sistema Único de Saúde. Sendo assim trata-se do eixo principal de compreensão da política de saúde no Brasil. As demais aulas também tratam de normativas (leis, decretos e portarias) muito importantes para estruturação e organização do sistema, mas para efeito de provas e concursos não há outro documento sobre o qual se pergunte mais. Para ser coerente com isto, esta será a aula com o maior número de questões de todo o nosso curso.

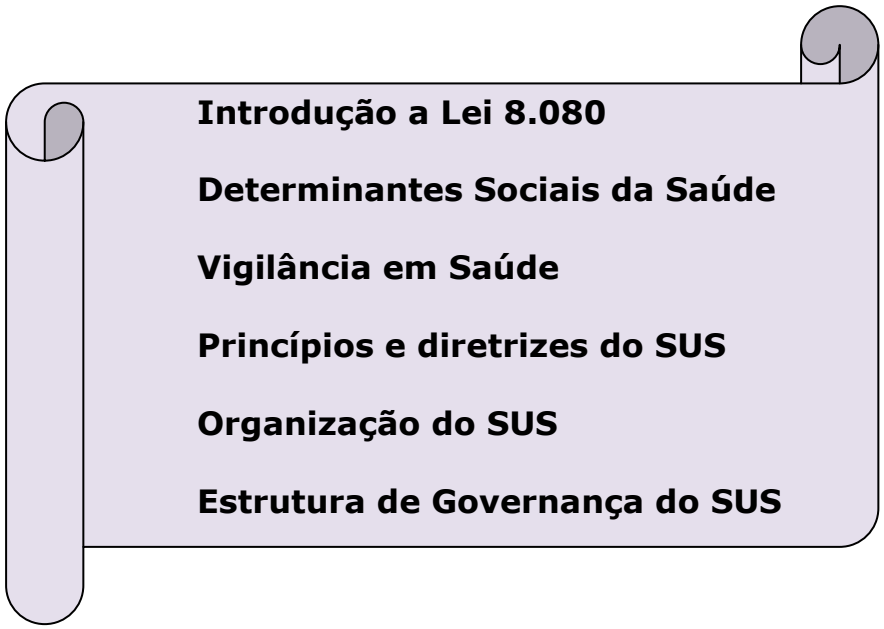
O enfoque desta aula será destrinchar a Lei 8.080, destacando os aspectos que aparecem como maiores tendências nas provas de concurso.

Trata-se de um tema bastante denso e extenso, pois como eu já disse em outras palavras, esta lei é a coluna vertebral de toda a legislação do SUS. Para tanto apresentarei um quadro resumo dos artigos da lei, e não trarei na íntegra o corpo do texto da lei. Você pode conferir o

texto completo com comentários no artigo que publiquei em nossa página chamado Lei 8.080 Esquematizada.

Incentivo-o (a) a realizar a leitura da lei propriamente dita logo após a apreciação cuidadosa do quadro resumo. Baixar o texto da lei 8080 pela internet é muito simples, basta digitar lei 8.080 / lei orgânica do SUS - no seu buscador preferido ou colocar o endereço abaixo direto na barra de endereços do seu browser - www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm. Prefira versões publicadas oficialmente por portais de órgãos do governo federal para garantir que terá acesso à todas as atualizações já feitas.

Logo após o resumo exploraremos os principais conceitos de que tratam o conjunto de capítulos e artigos da lei 8.080 e as questões relacionadas a eles. A ordem em que apresentarei essas abordagens segue a sequência em que eles aparecem em seus respectivos artigos no texto da lei. Outros aspectos importantes da lei como controle social, atenção materna, atenção domiciliar etc. serão trabalhados nas próximas aulas. Confiram os destaques desta aula no mural abaixo:



A LEI ORGÂNICA DA SAÚDE – LEI 8.080

Retomando do ponto onde paramos na aula passada, a Constituição Federal de 1988, trouxe claramente em seu texto o entendimento do que passava a significar a Seguridade Social para a sociedade brasileira. Resgatando também um destaque da história da saúde no período pré-SUS, podemos afirmar que os pontos da Constituição que se referem à saúde em grande parte foram inspirados no relatório da histórica **8ª Conferência Nacional da Saúde**, realizada em 1986 por reivindicação de grupos da sociedade civil organizada.

Sem dúvidas o maior ganho simbólico e concreto que obtivemos com a promulgação da nova Constituição foi o reconhecimento claro e inequívoco de que a saúde passaria a ser entendida enquanto um direito inalienável de toda e qualquer pessoa que esteja presente em território brasileiro.

A **Lei nº 8.080/1990**, também chamada de **Lei Orgânica da Saúde**, traz em seu cabeçalho e já no primeiro artigo um resumo muito esclarecedor sobre o seu teor. Esta lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção, recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes (cabeçalho) e regula em todo o território nacional as ações e os serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado (artigo 1º).

Isso quer dizer que é uma lei que determina os modos de funcionamento de todo e qualquer serviço de saúde e não só dos que são mantidos pelo poder público. Isso significa também que o SUS é composto por todos esses serviços e não apenas pelos públicos, ressalvando-se que a inciativa privada tem um caráter complementar e/ou suplementar nesse sistema. Entendimento este bastante diferente ao que observamos no senso comum.

A Constituição Federal remeteu a regulamentação do SUS à necessidade de aprovação de leis complementares e ordinárias e, desde então, foram aprovadas pelo Congresso Nacional as seguintes leis, emenda e decreto sobre o tema, com seus respectivos cabeçalhos:

1) **Lei nº 8.080**, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.

2) **Lei nº 8.142**, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

3) **Emenda Constitucional nº 29**, de 13 de setembro de 2000, que altera os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.

4) **Decreto nº 7.508,** de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.

5) **Lei Complementar nº 141**, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, por estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo;

Confira abaixo o quadro resumo que explica o teor de cada capítulo, sem dividir minuciosamente em cada artigo, para não perdermos o foco da compreensão sistêmica dos temas e não só da memorização.

QUADRO RESUMO – LEI 8.080		
TÍTULO		**ASSUNTO**
TÍTULO I **DISPOSIÇÕES GERAIS**		➢ Reafirma a **saúde enquanto direito e dever do Estado**, concretizando-se pela formulação e execução de políticas que garantam um **acesso universal e igualitário** as ações e serviços de saúde. ➢ Descreve o que são **determinantes de saúde**.
TÍTULO II **DO SUS**		➢ O SUS é formado por órgãos das **3 esferas de poder** – municipal, estadual e federal por meio de instituições de **administração direta e indireta**. ➢ Poderá contar com a participação da **iniciativa privada** em caráter **complementar**.
CAPÍTULOS	**ARTIGO**	
I **Objetivos** **Atribuições**	**5º e 6º**	➢ **Objetivos do SUS:** identificação de determinantes, formulação de políticas, assistência integral e prevenção. ➢ **Atuação do SUS:** vigilâncias (inclusive nutricional); assistência integral; participação no saneamento básico; ordenamento na formação de RH; colaboração na proteção ambiental; formulação de políticas de medicamentos, equipamento e materiais; fiscalização de serviços, produtos, substâncias e alimentos; desenvolvimento tecnológico; política de sangue. ➢ **Definição das vigilâncias:** epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.
II **Princípios** **Diretrizes**	**7º**	➢ **Princípios do SUS:** universalidade, equidade, integralidade, controle social, preservação da autonomia, direito a informação, priorização epidemiológica, participação da comunidade e descentralização, intersetorialidade, conjugação de recursos, resolutividade, evitar duplicidade.
III **Organização** **Direção** **Gestão**	**8º - 14**	➢ Organização **regionalizada e hierarquizada**; ➢ **direção única** a ser exercida pelo Ministério e Secretarias (municipais e estaduais); ➢ municípios podem formar **consórcios**; ➢ criação de **comissões intersetoriais** para assuntos que extrapolam a esfera do SUS; criação de comissões permanentes **de integração saúde e ensino**; ➢ **CIB e CIT** como foros de pactuação; ➢ **CONASS e CONASEMS** como entidades representativas das Secretarias de Saúde; **COSEMS** como representantes das Secretarias Municipais no âmbito dos Estados.
IV **Competência**	**15 - 19**	➢ **Atribuições "comuns"** da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. ➢ **Competências "específicas"** da direção nacional, estadual e municipal. O **Distrito Federal acumula**

Atribuições		competências de Estado e Município.
V **Saúde Indígena**	**19: A - H**	➢ Instituição do **Subsistema de Atenção à Saúde Indígena** com base nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas **(DSEI)**. ➢ Financiamento federal, Estado e Municípios poderão complementar. ➢ Articulação do Subsistema com os órgãos responsáveis pela Política Indígena. ➢ Levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas. ➢ O Subsistema deverá ser **descentralizado, hierarquizado e regionalizado**. ➢ SUS servirá de **retaguarda e referência**. ➢ Direito a **participar dos Conselhos de Saúde**.
VI **Internação Domiciliar**	**19 – I**	➢ Estabelecimento do atendimento e internação domiciliar no SUS, realizados por **equipes multidisciplinares** que atuarão na **prevenção, terapêutica e reabilitação**. ➢ Este atendimento só poderá ocorrer com expressa **concordância do paciente**.
VII **Parto e Pós-parto**	**19: J e L**	➢ Permissão da presença de 1 acompanhante durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto, indicado pela própria parturiente. ➢ Os hospitais devem manter, em local visível, aviso informando sobre este direito.
VII **Incorporação de Tecnologia**	**19: M-U**	➢ Define o que compõe a **assistência terapêutica integral:** dispensação de medicamentos e produtos; oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar; ➢ Detalha procedimentos da **política de medicamentos**; ➢ Descreve a composição da Comissão Nacional de **Incorporação de Tecnologias no SUS** e algumas de suas atribuições e procedimentos;
TÍTULO III – SERVIÇOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA		
I **Funcionamento**	**20 - 23**	➢ Define e caracteriza as possibilidades de **atuação da iniciativa privada no sistema de saúde**, respeitando as regras expedidas pelos órgãos gestores do SUS. ➢ Permite **participação** direta ou indireta **de empresas ou capital estrangeiro** na assistência, em alguns casos.
II **Participação Complementar**	**24 - 26**	➢ O SUS poderá recorrer a **iniciativa privada para complementar** seus serviços. ➢ Essa participação deve ser **por meio de contrato ou convênio.** ➢ Entidades **Filantrópicas** e **sem fins lucrativos tem preferência**. ➢ Os **critérios, valores e parâmetros** assistenciais serão

		estabelecidos pela direção nacional do SUS e **aprovados no Conselho Nacional de Saúde** (CNS). ➢ Aos proprietários e dirigentes de entidades contratadas é vedado exercer cargo de confiança no SUS.
TÍTULO IV – RECURSOS HUMANOS		
	27 - 30	➢ **Objetivos da política de recursos humanos**: organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino; valorização da dedicação exclusiva aos serviços do SUS. ➢ Os **serviços públicos constituem campo de prática** para ensino e pesquisa. ➢ **Os cargos e funções** de chefia, direção e assessoramento, só poderão ser **exercidas em regime de tempo integral**. ➢ Servidores que acumulam **2 cargos** poderão exercer suas **atividades em mais de 1 estabelecimento**. ➢ As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão (**Programas de Residência**) serão **regulamentadas por Comissão Nacional**.
TÍTULO V – FINANCIAMENTO		
I **Recursos**	**31 - 32**	➢ O **orçamento da seguridade social** destinará ao SUS os recursos necessários, **de acordo com a LDO**. ➢ Define outras fontes de recursos. ➢ **Atividades de pesquisa** e desenvolvimento científico e tecnológico serão **co-financiadas** pelo SUS, pelas universidades e com recursos de instituições de fomento.
II **Gestão Financeira**	**33 -35**	➢ **Recursos financeiros** movimentados ficam sob **fiscalização** dos respectivos **Conselhos de Saúde**. ➢ Na esfera federal, os recursos financeiros serão administrados pelo **Fundo Nacional de Saúde (FNS)**. ➢ **Auditoria do MS** acompanha a **aplicação dos recursos** repassados conforme programação. ➢ **Critérios** para o estabelecimento de **valores a serem transferidos** para Estados e Municípios.
III **Planejamento Orçamento**	**36 - 38**	➢ **Planejamento e orçamento** devem ser **ascendentes**. ➢ Vedado o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais. ➢ **Não é permitido auxílio financeiro** à instituições prestadoras de serviços **com finalidade lucrativa**.
DISPOSIÇÕES FINAIS		
➢ O **acesso aos sistemas de informação** dos ministérios da seguridade social será assegurado às Secretarias de Saúde, e o MS deve organizar um sistema nacional. ➢ **Hospitais universitários** e de ensino integram-se ao SUS, mediante **convênio**. ➢ Em tempos de paz serviços das **Forças Armadas** poderão integrar-se ao SUS.		

Se você já leu o texto original desta lei ou estudou a respeito dela há algum tempo atrás vai se surpreender com as novidades incrementadas por leis subsequentes que provocaram alterações em vários de seus capítulos e artigos. Confira abaixo a lista de todas estas leis e decreto com seus respectivos cabeçalhos, que você também encontrará distribuído no texto da última versão da lei 8.080. Fique atento à estas leis, sobretudo às que são mais recentes, elas podem se tornar uma tendência para provas que estejam por vir.

Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995

Regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999

Acrescenta dispositivos à Lei 8.080, que "dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências", instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

Lei nº 10.424, de 15 de abril de 2002

Acrescenta capítulo e artigo à Lei 8.080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de serviços correspondentes e dá outras providências, regulamentando a assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde.

Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005

Altera a Lei 8.080, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Lei nº 12.401, de 2011

Altera a Lei 8.080, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS.

Lei nº 12.466, de 24 de agosto de 2011

Acrescenta arts. 14-A e 14-B à Lei 8.080, que "dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências", para dispor sobre as comissões intergestores do Sistema Único de Saúde (SUS), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e suas respectivas composições, e dar outras providências.

Lei nº 12.864, de 24 de setembro de 2013

Altera a Lei 8.080, incluindo a atividade física como fator determinante e condicionante da saúde.

Lei nº 12.895, de 18 de dezembro de 2013.

Altera a Lei 8.080, obrigando os hospitais de todo o País a manter, em local visível de suas dependências, aviso informando sobre o direito da parturiente a acompanhante.

Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015

Altera o arts. 23 e 53 da Lei 8.080, permitindo a participação de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde.

Mesmo que esta primeira parte seja mais de contextualização quero te mostrar desde já como são as questões sobre esta aula

AOCP – EBSERH/HC-UFG – 2015

21) Assinale a alternativa correta.

(A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

(B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.

(C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

(D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.

(E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

Comentário

Já na sua disposição preliminar a lei 8.080 define quais serviços fazem parte do SUS em todas as esferas de gestão sejam os de administração direta (estrutura própria) ou indireta (convênios, contratos etc.). Assim a alternativa correta está na letra A.

Entre as alternativas erradas, que me parecem um tanto óbvias, acho que vale comentar apenas que a iniciativa privada pode fazer parte do SUS, mas com caráter complementar e não concorrente.

SESAP/RN – CONSULPLAN – 2008

13) A partir da promulgação da nova Carta Constitucional em outubro de 1988, iniciou-se o processo de elaboração da Lei Orgânica de Saúde (LOS) - Lei 8080/1990, sancionada com vetos pelo Presidente da República. Sobre este assunto, nas alternativas abaixo marque V para as verdadeiras e F para as falsas:

( ) A LOS integrou os principais aspectos já consagrados na Constituição - saúde como direito do cidadão e dever do Estado.

( ) Promover também à LOS a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) com seus princípios de universalidade, equidade e integralidade das ações.

( ) Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo, destacando a municipalização, que também foi prevista pela LOS.

( ) A LOS ampliou o conceito de saúde incluindo sua caracterização social.

A sequência está correta em:

A) V,V,V,V.

B) V,V,V,F.

C) F,F,F,F.

D) V,F,F,V.

E) V,V,F,F.

Comentário

Aqui começo a utilizar questões específicas de provas da carreira de Auditor Fiscal de Vigilância Sanitária e outras análogas. Apesar das 2 afirmativas que estão no meio estarem redigidas de forma confusa, não há entre as afirmativas nenhuma que esteja errada. De fato a 8080 consagrou os aspectos que haviam sido tratados na CF, os princípios do SUS que estão mencionados na afirmativa seguinte estão corretos, a descentralização foi um eixo importante da 8080 e ela certamente resgatou o caráter social da saúde. Por isso a resposta é letra A.

DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE

Damos início a esta etapa da aula destacando um primeiro conceito muito importante que aparece logo nas Disposições Gerais do Título I, os determinantes e condicionantes da saúde. Isso revela de alguma forma o entendimento da sociedade brasileira sobre o que é saúde, compartilhando de uma visão de homem integral. Vejamos como ficou o texto deste artigo:

"Art. 3º - Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais."

> Lembre-se que na lista de leis que alteraram o texto original, que acabamos de ver, consta o acréscimo da atividade física como um determinante de saúde. **(Lei nº 12.864, de 24 de setembro de 2013)**

De acordo com definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), os **determinantes sociais da saúde estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha**. Também podem ser considerados os **fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais** que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população, tais como **moradia, alimentação, escolaridade, renda e emprego**.

O esquema abaixo, proposto pelos teóricos Dahlgren e Whitehead, ilustra bem a interrelação entre estes determinantes sociais (representados graficamente pelos arcos) e o grupo de fatores e características individuais (representados na esfera central) sobre as quais não se tem muita possibilidade de intervenção ou alteração.



Estudos sobre determinantes sociais apontam que há distintas abordagens possíveis. Além disso, que há uma variação quanto à compreensão sobre os mecanismos que acarretam em iniquidades de saúde. Por isso, **os determinantes sociais não podem ser avaliados somente pelas doenças geradas**, pois vão além, influenciando todas as dimensões do processo de saúde das populações, tanto do ponto de vista do indivíduo, quanto da coletividade na qual ele se insere.

Entre os desafios para entender a relação entre determinantes sociais e saúde está o estabelecimento de uma hierarquia de determinações entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica, política e as mediações através das quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas, **não havendo uma simples relação direta de causa-efeito**.

Daí a importância do setor saúde se somar aos demais setores da sociedade no combate às iniquidades, ao que chamamos de **intersetorialidade**. Todas as políticas que assegurem a redução das desigualdades sociais e que proporcionem melhores condições de mobilidade, trabalho e lazer são importantes neste processo, além da própria conscientização do indivíduo sobre sua participação pessoal no processo de produção da saúde e da qualidade de vida.

Encontramos um número considerável de questões acerca deste tema

IBFC – EBSERH-HU/UFMA – 2013

23) Considerando os determinantes sociais de saúde, assinale a alternativa incorreta:

(A) As redes sociais ou comunitárias, expressas pelo nível de coesão social têm pouca importância para a saúde da sociedade como um todo.

(B) Características individuais de idade, gênero e fatores genéticos exercem influência sobre seu potencial e suas condições de saúde.

(C) Educação e habitação são determinantes fundamentais de saúde.

(D) Trabalho e desemprego são determinantes fundamentais de saúde.

(E) A produção agrícola de alimentos é um determinante social de saúde.

Comentário

Não se trata de uma questão difícil, mas ela é bem conceitual, não encontramos no texto da lei algo descrito nestes termos. Portanto, memorizar o que consta na lei não seria suficiente para responder este e outros tipos de questões mais elaboradas.

Observe que no texto destaquei alguns fatores relacionados aos determinantes sociais de saúde, tais como: sociais, econômicos, culturais, psicológicos, moradia, alimentação, escolaridade e empregabilidade. Além do que trouxe um modelo ilustrativo que demonstra a correlação entre estes fatores de determinação social e os de âmbito individual. Assim, a única alternativa que não pertence a este contexto é a letra A. Até porque esta alternativa nega a importância de um fator inquestionavelmente relevante, as relações em comunidade.

IBFC – EBSERH/HU-UNIVASF – 2014

25) Considerando os determinantes de saúde, não pode ser considerado um determinante social de saúde:

(A) Produção agrícola de alimentos.

(B) Educação.
(C) Ambiente de trabalho.
(D) Habitação.
(E) Idade.

Comentário

A partir do esquema teórico de Dahlgren e Whitehead você consegue se lembrar mais facilmente sobre a correlação, mas também a diferenciação entre os fatores sociais e individuais que influenciam a saúde das pessoas. No caso desta questão a idade é claramente um fator individual sobre o qual não se tem governabilidade, pois a despeito dos esforços da indústria coméstica, ainda não inventaram uma máquina de rejuvenescer (rs). Portanto a resposta correta é E.

IBFC – EBSERH-HU/UFMA – 2013

23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:
(A) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
(B) Há associação entre estilos de vida sedentários e maior prevalência de hipertensão arterial.
(C) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
(D) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
(E) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturados e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

Comentário

Estamos novamente diante de uma questão bem interessante, pois ela traz uma aplicação prática para o conceito de determinantes sociais de saúde. Todas as associações feitas nesta questão estão corretas, portanto a única alternativa incorreta é a letra A. Certamente a renda familiar influencia na saúde, sejá pelo estresse provocado por esta preocupação ou a falta de condições objetivas para uma alimentação adequada.

AOCP - EBSERH/HC-UFG – 2015

21) Assinale a alternativa correta.

(A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso preferencial aos mais pobres às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(B) O dever do Estado de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

(C) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

(D) As fundações mantidas pelo Poder Público e a Administração Pública Indireta não fazem parte do Sistema Único de Saúde.

(E) A iniciativa privada deverá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter complementar.

Comentário

Num primeiro olhar esta questão parece estar explorando apenas memorização, mas não é, ela exige um grau considerável de compreensão do que significam alguns dos primeiros artigos da 8.080. Eis alguns erros das alternativas: a política de saúde não é restritiva aos pobres e a nenhum extrato social da sociedade (art. 2º); o dever do Estado não substitui ou dispensa a responsabilidade dos próprios indivíduos sobre sua saúde e das demais instituições da sociedade como a família e empresas (art. 2º); as fundações, seja lá de qual natureza, fazem parte do SUS (art. 4º); a iniciativa privada poderá participar do SUS, mas não tem isso como dever (art. 4º). A única descrição correta está na letra C, que a propósito já traz a versão mais recente, atualizada pela lei 12.864, promulgada em 2015.

IBFC – EBSERH – 2013

22) A lei 8080/1990 NÃO incluiu no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS:

(A) A participação na formulação da política e na execução de ações de combate à fome e distribuição de renda.

(B) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

(C) A vigilância nutricional e orientação alimentar.

(D) A colaboração na proteção do meio ambiente.

Comentário

Mesmo que você ainda não tenha lido o texto da lei 8.080 na íntegra, pelo quadro resumo você é capaz de identificar que a ordenação de recursos humanos, a vigilância nutricional e a colaboração do meio ambiente estão no campo de atuação do SUS. Já o combate a fome e distribuição de renda, mesmo sendo fatores que influenciam na saúde das pessoas, pertencem ao campo de atuação da Política de Assistência Social, que é executada pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A vigilância em saúde **tem por objetivo a observação e análise permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações** que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

As ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, devem se constituir em espaço de articulação de conhecimentos e técnicas. O conceito de vigilância em saúde inclui: **a vigilância e o controle das doenças transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis; a vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária**.

Observamos em seu artigo 6º, que a lei 8.080 elenca as facetas da vigilância em Saúde como objetivos de atuação do SUS.

Art. 6º - Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
I - a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
c) de saúde do trabalhador;

As ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, devem se constituir em espaço de articulação de conhecimentos e técnicas. Segundo a **Portaria nº 1.378 de 2013** as ações de Vigilância em Saúde envolvem práticas e processos de trabalho voltados para:

- vigilância da situação de saúde da população, com a produção de análises que subsidiem o planejamento, estabelecimento de
- prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação das ações de saúde pública;
- detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta às emergências de saúde pública;
- vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis;
- vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, dos acidentes e violências;
- vigilância de populações expostas a riscos ambientais em saúde;
- vigilância da saúde do trabalhador;
- vigilância sanitária dos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse a saúde;

Assim, apesar do Ministério da Saúde e dos demais gestores da saúde no âmbito estadual e municipal ainda não terem concluído a formulação da **Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS)**, podemos afirmar que os eixos estruturantes desta política estão bem representados no esquema abaixo:



A ideia de representar a PNVS por meio deste esquema é demonstrar que apesar de haverem dimensões distintas do trabalho de vigilância em saúde, estas dimensões devem ser entendidas de maneira integrada. Nesta aula destacaremos apenas os 3 eixos de que se faz menção clara no texto da lei e por estarem mais presentes nas provas.

Vigilância Sanitária

De acordo com o parágrafo 1º do artigo 6º, a definição que temos de vigilância sanitária é:

"...um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde..."

Este conceito abrange o **controle de bens de consumo** que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo. Atua também no **controle da prestação de serviços** que, direta ou indiretamente, se relacionam com a saúde.

A vigilância sanitária também pode ser concebida como um **espaço de exercício da cidadania e do controle social**, por sua capacidade transformadora da qualidade dos produtos, dos processos e das relações sociais.

Vigilância Epidemiológica

De acordo com o parágrafo 2º do artigo 6º, a definição que temos de vigilância epidemiológica é:

... "um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos"...

Seu propósito é **fornecer orientação técnica permanente** para os que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos. Tem como funções, dentre outras: coleta e processamento de dados; análise e interpretação dos dados processados; divulgação das informações; investigação epidemiológica de casos e surtos; análise dos resultados obtidos; e recomendações e promoção das medidas de controle indicadas.

A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções específicas e complementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo **conhecer**, a cada momento, **o comportamento da doença ou agravo selecionado como alvo das ações**, de forma que as medidas de **intervenção pertinentes possam ser desencadeadas em tempo oportuno e com eficácia**.

Saúde do Trabalhador

De acordo com o parágrafo 3º do artigo 6º, a definição que temos de saúde do trabalhador é:

"...um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho..."

Em resumo, as principais ações compreendidas pela política de saúde do trabalhador, conforme a própria lei 8.080 prevê, são:

- assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho;
- participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho;
- participação da normatização, fiscalização e controle das condições que apresentam riscos à saúde do trabalhador;
- informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho e doença do trabalho.
- participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas;
- revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais;

Busquei trazer nesta parte da aula questões com alternativas abrangentes que exploram bem o assunto.

Pref. Castelo/ES – COMAJ – 2007

24) De acordo com a Lei nº 8080/90, estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde SUS a execução de ações. Marque a alternativa correta:

A) De vigilância sanitária.

B) De vigilância epidemiológica.

C) De saúde do trabalhador.

D) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

E) Todas as alternativas estão corretas.

Comentário

Resolvi iniciar esse bloco por uma questão mais fácil. Perceba que as alternativas listam justamente as ações que constam no primeiro inciso do artigo 6º da lei 8080. Estas ações foram os destaques desta parte da aula, com exceção da assistência terapêutica integral que será melhor explorada em outra parte desta aula e de outras deste mesmo curso. De qualquer forma a resposta correta está na letra E.

SESAP/RN – CONSULPLAN – 2008

20) A Lei Federal nº 8080/1990 em seu artigo 6º determina a inclusão no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução das ações de vigilância, EXCETO:

A) Vigilância Sanitária das cozinhas industriais de restautantes.

B) Vigilância à Saúde do Trabalho

C) Vigilância ao trabalho escravo em fazendas.

D) Vigilância Epidemiológica.

E) Vigilância à assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

Comentário

Esssa questão é bem parecida com a anterior mas tentou enfocar apenas as dimensões da vigilância em saúde. Apesar da alternativa A fazer um recorte restrito a vigilância sanitária, não se pode dizer que esteja errado. Já na alternativa C está completamente fora do contexto da Política Nacional de Vigilância em Saúde. O problema maior é que a alternativa E também foi distorcida pois este último item do artigo 6º não se trata de vigilância e sim de atenção integral à saúde.

Portanto apesar do gabarito só apontar para a letra C, caberia um recurso pois a letra E também está errada.

Pref. Abelardo Luz/SC – ICAP – 2011

14) Dentre os objetivos do Sistema Único de Saúde SUS estão a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, e a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, conforme identifica o Artigo 5 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990. Para cumprir estes objetivos, o Sistema Único de Saúde promove a execução de ações, por exemplo, através dos departamentos de:

I. Vigilância Sanitária.

II. Vigilância Epidemiológica.

III. Vigilância Ambiental em Saúde.

Relacione abaixo as ações exercidas por cada um dos departamentos citados acima:

( ) Conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde.

( ) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

( ) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Assinale a alternativa que contém a associação correta das colunas acima:

a) I, II, III.

b) I, III, II.

c) II, III, I.

d) III, II, I.

e) III, I, II.

Comentário

Não sei se você percebeu que o enunciado desta questão já começa tropeçando ao referir o artigo 5 ao invés do 6º. E apesar de ser algo bem comum que tanto o Ministério da Saúde quanto as secretarias de saúde (municipais e estaduais) tenham um departamento de vigilância ambiental ou análogo, acho delicado que essa banca tenha associado o trabalho deste ramo da vigilância em saúde à lei 8080, uma vez que essa lei não faz nenhuma menção direta ao tema, ainda que se encontre nela várias referências da correlação do meio ambiente e da saúde humana.

De toda forma, creio que não tenha sido muito difícil você identificar termos chave (risco ambientais, controle das doenças e problemas sanitários) que te permitam distinguir quais seriam os conjuntos de ação de cada um destes departamentos. Leia atentamente cada uma das definições nesta questão, elas podem ajudá-lo(a) a entender melhor esse tema. A resposta está na letra D.

AOCP – EBSERH/HDT-UFT – 2015

23) De acordo com as definições trazidas pela Lei Orgânica da Saúde - Lei n° 8.080/1990, a Vigilância Epidemiológica:

(A) está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde e é definida como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

(B) está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde e é definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

(C) está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde e é definida como o controle exercido sobre todos os bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

(D) não está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde e é definida como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

(E) não está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde e é definida como o controle exercido sobre todos os bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

Comentário

Esta é uma questão composta por alternativas cujo texto é bem extenso, exige de você muita atenção na leitura. O primeiro movimento muito simples é descartar as duas últimas alternativas por afirmarem logo no início que a vigilância epidemiológica não está incluída no campo de atuação do SUS. A alternativas A e C trazem como diferencial a idéia de intervir e controlar as diferentes etapas da cadeia de produção, o que nos remete a um papel fiscalizatório bem característico da Vigilância Sanitária (VISA). Resta apenas então a alternativa B, que define a Vigilância Epidemiológica exatamente conforme consta no texto da lei.

Pref. Castelo/ES – COMAJ – 2007

21) De acordo com a Lei nº 8080/90, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores, submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, exceto:

A) Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.

B) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde - SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.

C) O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

D) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde - SUS, da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, produtos, máquinas e equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador.

E) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.

Comentário

Encontramos nesta prova de um concurso municipal ao menos uma questão a respeito da saúde do trabalhador. Certamente este é um tema mais comum em concursos de vagas específicas desta área.

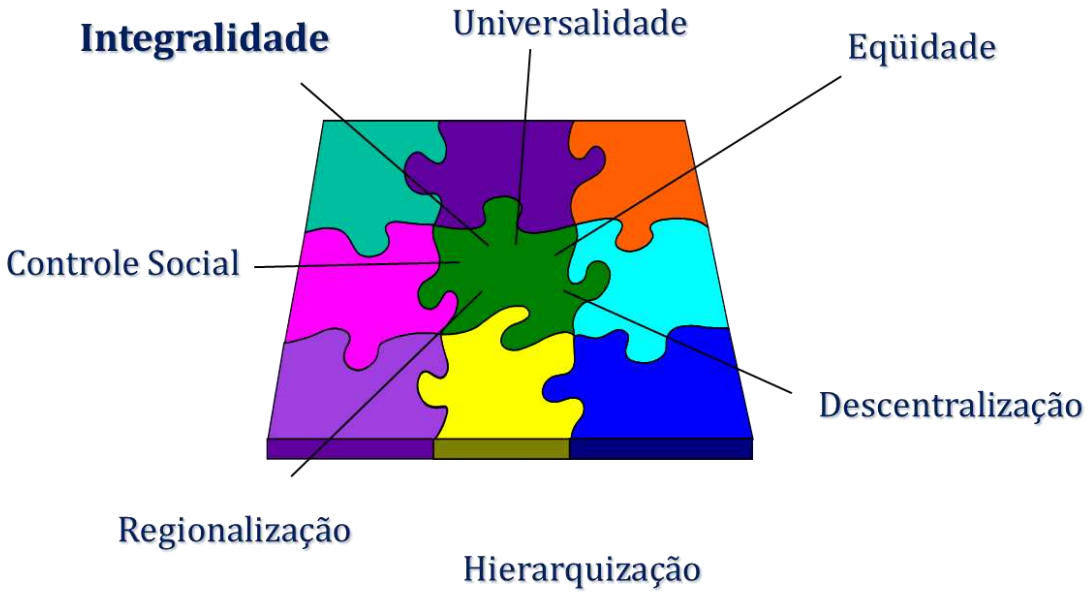
As ações em saúde do trabalhador englobam o aspecto assistencial, preventivo e promocional. Inclui também o desenvolvimento de pesquisas relacionadas a fatores que influenciam a saúde das pessoas e que estejam ligadas a sua atividade laboral e ações de fiscalização sobre tudo o que fora mencionado neste parágrafo. Todavia nada tem a ver com o controle de prestação de serviços, isto estaria melhor relacionado a sistemas de controladoria, auditoria e afins. Portanto a resposta é C.

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS

Chegamos ao coração e alma da lei 8.080, a expressão maior dos valores defendidos nos primórdios pelo movimento da reforma sanitária brasileira, e que cotidianamente permanece como a bandeira de cada um dos que militam pelo direito à saúde.

Alguns destes princípios e diretrizes já nos foram apresentados ao estudarmos a Constituição Federal. Na lei orgânica **estes princípios encontram-se agrupados no artigo 7º**, conforme podemos observar no quadro resumo. Porém, na verdade eles estão espalhados sutilmente nas descrições de vários outros artigos também. Vale destacar também que a lei é bem clara ao declarar que **esses princípios se aplicam ou deveriam se aplicar a todos os serviços públicos, privados, contratados ou conveniados que integram o SUS.**

Não estivéssemos em um curso focado, poderíamos fazer de cada um destes princípios um mote para uma aula própria. Trago-lhes, porém, uma proposta de glossário que resume cada um destes conceitos tão caros ao SUS, antecedido por uma imagem que nos lembra que estes princípios precisam andar completamente integrados.



Princípios Doutrinários

Universalidade: significa que o Sistema Único de Saúde deve atender a todos por meio de sua estrutura e serviços, sem distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção necessária, sem qualquer custo. Não importando, por exemplo, se a pessoa possui um plano de saúde privado.

Equidade: preconiza o direito das pessoas de serem atendidas de acordo com as suas necessidades de saúde, sem privilégios ou preconceitos. O SUS deve disponibilizar recursos e serviços de forma justa, de acordo com as necessidades de cada um. Portanto, não é sinônimo de igualdade, apesar do texto da lei colocar nestes termos e estes conceitos terem muito em comum. Ocorre que esta concepção evoluiu, visando entre outros aspectos reduzir o impacto dos determinantes sociais da saúde que acabamos de estudar.

Integralidade: preconiza a garantia ao usuário de uma atenção que abrange as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de acesso a todos os níveis de atenção do Sistema de Saúde. A integralidade também pressupõe a atenção focada no indivíduo, na família e na comunidade (inserção social) e não num recorte de ações programáticas ou doenças.

Princípios Organizativos

Regionalização: trata-se de uma forma de organização do Sistema de Saúde, com base territorial e populacional, adotada por muitos países na busca por uma distribuição de serviços que promova equidade de acesso, qualidade, otimização dos recursos e racionalidade de gastos.

Hierarquização: diz respeito à possibilidade de organização dos níveis de atenção do Sistema conforme o grau de densidade tecnológica dos serviços, isto é, o estabelecimento de uma rede que articula os serviços dos diferentes níveis de atenção, através de um sistema de referência e contra-referência de usuários e de trânsito de informações.

Descentralização: é o processo de transferência de responsabilidades da gestão e recursos para os municípios, atendendo às determinações constitucionais e legais que embasam o SUS e que definem atribuições comuns e competências específicas à União, estados, Distrito Federal e municípios.

Controle Social: é um mecanismo institucionalizado pelo qual se procura garantir a participação social, com representatividade, no acompanhamento da formulação e execução das políticas de saúde. Ele se concretiza primordialmente por meio dos Conselhos e Conferências de Saúde, mas se dá também em outras instâncias.

Além destes princípios mais estruturantes do Sistema, sobre os quais muito se escreve, o **artigo 7º menciona ainda os seguintes princípios e diretrizes:**

- **preservação da autonomia** das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
- **direito à informação**, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
- **divulgação de informações** quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;
- **utilização da epidemiologia** para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
- **integração em nível executivo das ações de saúde**, meio ambiente e saneamento básico;

- **conjugação dos recursos financeiros**, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;
- **capacidade de resolução dos serviços** em todos os níveis de assistência;
- organização dos serviços públicos de modo a **evitar duplicidade de meios para fins idênticos.**

Há de se lembrar ainda que **este artigo da lei 8.080 se baseia no artigo 198 da Constituição**. A lei teve a pretensão de detalhar, dando assim maior clareza aos princípios constitucionais. O texto da Constituição diz o seguinte:

Art. 198. *As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:*
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.

A seguir temos a maior bateria de questões desta aula, o que demonstra que é muito importante que você esteja afiado quanto a este assunto.

IBFC – SEPLAG/FUNED/MG – 2014

16) A Atenção à Saúde deve levar em conta as necessidades específicas de pessoas ou grupo de pessoas ainda que minoritários; ou seja, a cada qual de acordo com suas necessidades, inclusive no que é pertinente aos níveis de complexidade diferenciados. Essas premissas se referem a um dos princípio do Sistema Único de Saúde SUS, que é a:

A) Universalidade.

B) Integralidade.

C) Igualdade da assistência à saúde.

D) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.

Comentário

Mais uma questão polêmica passível de recurso para anulação. O enunciado desta questão provavelmente foi copiado de um artigo científico que trata a respeito da integralidade. Porém, fora de contexto, essa descrição se aproxima muito do conceito de equidade. Por um lado ele até fala do atendimento as necessidades específicas das pessoas e de que as mesmas podem ser atendidas em níveis de complexidade diferenciados, aspectos claramente ligados a ideia de integralidade.

Já quando fala de grupos minoritários e de atender a cada qual conforme suas necessidades, é aí que se confunde com a equidade. Ainda bem que ao menos não há uma alternativa que refere exatamente a equidade, apesar de trazer a igualdade da assistência à saúde. De toda forma o gabarito é letra B.

AOCP – EBSERH/HC-UFG – 2015

22) Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

(A) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

(B) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

(C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

(D) Participação da comunidade.

(E) O atendimento prioritário aos pobres, das crianças e mulheres.

Comentário

Nesta primeira questão vemos 4 alternativas que trazem afirmações exatamente tal qual encontramos na lei: as diretrizes de conjugação financeira e de organização dos serviços para evitar duplicidade e os princípios de preservação da autonomia das pessoas e participação da comunidade. De fato a única alternativa que está destoando é a de letra E, em algumas circunstâncias indivíduos dos grupos populacionais descritos nesta alternativa podem até vir a se configurarem em mais vulneráveis, o que justificaria que uma priorização a partir do princípio da equidade. Todavia, estabelecer essa preferência a priori fere o princípio da universalidade, pois dá a entender que o sistema atenderá primeiro estes grupos e depois, se for possível, atenderá os demais.

IBFC – EBSERH – 2013

22) A lei 8080/90 não inclui entre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde:

(A) Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.

(B) Utilização da estratificação de risco como estratégia para a Atenção de Urgência e Emergência.
(C) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
(D) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Comentário

Nesta questão creio que você facilmente relacionou as alternativas A e C como parte dos princípios primordiais de constituição do SUS. Mas numa releitura atenta você perceberá que a questão do financiamento também está listada ao final do artigo 7º, de maneira exatamente igual ao que a alternativa D apresenta. Assim, temos como resposta correta a alternativa B. Comentarei outros aspectos na questão seguinte que é muito semelhante.

IBFC – EBSERH/HU-UNIVASF – 2014

22) A lei 8080/90 definiu princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Não consta entre esses princípios e diretrizes:
(A) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
(B) Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.
(C) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.
(D) Acolhimento ao usuário, com ênfase na estratificação de risco.
(E) Igualmente da assistência à saúde.

Comentário

Primeiramente faço uma ligeira ressalva de que a redação da alternativa E está gramaticalmente muito ruim. Como eu disse, essa questão é semelhante a anterior e portanto a resposta para ela é letra D.

Preciso, no entanto, ressaltar que a estratificação de risco é uma importante estratégia, sobretudo na atenção primária/básica para planejarmos o cuidado que dedicamos para os diferentes grupos populacionais que habitam um determinado território a depender da vulnerabilidade de cada um deles. Nos serviços de urgência, onde habitualmente chamamos isso de classificação de risco, o princípio por trás disso é o mesmo, trata-se de uma das maneiras de praticar a equidade. Porém, como a questão pede para identificar os princípios e não um dispositivo de aplicação dos mesmos, esta alternativa trazia a ideia do que não se inclui entre os princípios.

AOCP – EBSERH/HC-UFG – 2015

22) Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

(A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.

(B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

(C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.

(D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

(E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

Comentário 

Percebam que para este tema eles gostam de perguntar o que está errado para tentar confundir os candidatos. E a propósito esta questão quer te pegar nos detalhes mesmo, primeiro porque todas as alternativas se referem a principios que não estão entre os estruturantes. A resposta está na letra A, onde a ideia expressa estava correta até chegar na

palavra exceto. Mesmo pessoas em estado terminal tem direito de saber sobre sua condição de saúde.

IBFC – EBSERH/HU-UNIVASF – 2014

22) Um dos princípios do Sistema Único de Saúde, definido pela lei 8080/90 é:

(A) Ambiência.

(B) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.

(C) Não maleficência.

(D) Humanização da assistência em todos os seus níveis.

(E) Centralização político-administrativa.

Comentário

Mais uma questão sobre o mesmo princípio da anterior. A resposta é letra B. Destaco que muitas questões sobre este tema são como esta, trazem alternativas com ideias corretas e importantes para o SUS, mas que não estão inclusas na lei enquanto princípio. Tudo para te confundir.

AOCP – EBSERH/Nacional – 2015

22) Assinale a alternativa correta.

(A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde, nos primeiros níveis de assistência, é um dos princípios do Sistema Único de Saúde.

(B) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é dividida e descentralizada, sendo exercida a direção em cada esfera de governo.

(C) Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.

(D) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde não poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

(E) É princípio do Sistema Único de Saúde a organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos.

Comentário

Gostei do jeitão desta questão, ela vai produzindo pequenas distorções em ideias que na sua essência são corretas. A universalidade não se restringe aos primeiros níveis do sistema. A direção do SUS deve ser única e ser exercida por cada esfera de governo, aspectos esses constantes no artigo 8º e não 7º (como os demais princípios) e condizente com o artigo 198 da Constituição. Os municípios podem sim formar consórcios entre si para otimizarem seus processos de gestão. E os municípios podem sim formar distritos, e em muitos casos isso ajuda muito na organização do sistema local. Portanto a resposta é E.

AOCP – EBSERH/HE-UFSCAR – 2015

21) Assinale a alternativa correta.

(A) A saúde é um direito fundamental do ser humano e é um dever do Estado, não sendo responsabilidade da própria pessoa, da família, das empresas e da sociedade.

(B) A vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde.

(C) Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde: a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

(D) São campos de atuação do Sistema Único de Saúde, a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

(E) São princípios do Sistema Único de Saúde: a capacidade de resolução dos serviços, em todos os níveis de assistência e organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos.

Comentário

Já nesta questão as alternativas misturam diferentes maneiras de confundi-lo. Na alternativa A ele nega a responsabilidade da família como já vimos outra questão no primeiro tópico desta aula. Na B ele exclui as vigilâncias, que também já vimos nessa aula e portanto, sabemos que

não é verdade. A alternativa C é a certa porque reproduz corretamente a afirmação de que o SUS prentede a atenção integral aos sujeitos, inclusive a assistência farmacêutica. Na letra D ele se refere a um princípio legítimo mas se refere enquanto campo de atuação e não princípio. A letra E também está correta ao retratar 2 dos princípios que não estão entre os principais, mas que também são muito importantes. Portanto a questão foi anulada.

IBFC – EBSERH-HU/UFMA – 2013

22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi durante criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

(A) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque toma a vacinação demorada e com risco de menos cobertura.

(B) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.

(C) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.

(D) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.

(E) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.



Comentário

Novamente o IBFC surpreendeu, trouxe uma questão bastante conceitual e que exige uma análise a partir de uma situação prática que apesar de comum não é tão simples. Devido ao grau de complexidade identificarei meus comentários de acordo com apresentação de cada alternativa.

Na alternativa A não temos elementos para afirmar que a medida adotada fere o princípio da universalidade porque as equipes do município podem ter se organizado de modo a não permitir que este incremento de ações tenha prejudicado a oferta irrestrita da vacinação.

A alternativa C também não é defensável, pois o fato de ofertar estas ações a quem queira não significa que as pessoas estariam sendo forçadas ou se quer constrangidas a aceitá-las, portanto não fere o princípio da autonomia.

Na alternativa D novamente o enunciado da questão não nos concede elementos suficientes para que se afirme que o princípio do uso da epidemiologia não foi respeitado, pois a equipe de vigilância do município pode muito bem ter decidido por fazer essa combinação de ações após averiguar um índice muito alto de diabéticos e hipertensos em seu território.

A resposta correta, portanto, está na alternativa B, pois associar medidas que abranjam diferentes aspectos da saúde das pessoas e das comunidades demonstra uma preocupação com o princípio da integralidade, por mais que este exemplo não me pareça ser a melhor maneira de ilustrar isso. E aqui vale uma dica que se aplica a muitos casos, a alternativa B era a única que afirmava estar de acordo com algum princípio, as demais tinham todas uma conotação negativa. Toda vez você se deparar com uma alternativa que destoa das demais desconfie, não se precipite em optar por ela, pois nem sempre ela é a resposta correta, mas preste mais atenção nela como suspeita nº1.

IBFC – EBSERH/HU-UFMA – 2013

22) Dois municípios vizinhos se associaram com o abjetivo de melhorar a atenção à saúde. Decidiu-se que caberia ao município A a realização de mamografia, quando indicada para as pacientes de ambas as localidades. O município B seria o responsável pela realização de exame de prevenção

do câncer prostático em homens (clínico e dosagem de PSA - Antígeno Prostático Específico). Em sua opinião:

(A) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS.

(B) A medida está incorreta pois compromete o princípio da integralidade do SUS.

(C) A medida fere o princípio da divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.

(D) A medida está de acordo com o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

(E) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

Comentário

É desse tipo de questões que eu gosto, que te coloca para pensar como seria a aplicação de determinado princípio. A situação está descrita muito sucintamente, podendo nos levar a crer que há algo de errado no que foi feito pelos municípios. O fato é que esta é a realidade de muito município pequeno. Não se faz necessário que cada município possua todos os recursos que uma Rede de Atenção à Saúde deve dispor, isso deve prioritariamente ser ofertado na região de saúde em que cada um deles está inserido. Isso talvez dificulte o acesso, mas não fere os princípios da integralidade e resolutividade. Até porque dispor certos recursos para uma população pequena pode não ser custo-efetivo. Discutiremos mais sobre isso em nossa última aula. A resposta aqui é D, pois os municípios estão otimizando seu recurso e com isso evitando duplicidade para fins idênticos.

ORGANIZAÇÃO DO SUS

Para a discussão deste tema a proposta é partir de diferentes artigos da lei 8.080 que estejam diretamente relacionados a organização do SUS efetivamente e discutí-los para esclarecê-los. Alguns destes artigos encontram-se no **capítulo III**, cujo o título é justamente – **da organização, da direção e da gestão.** Faço abaixo um destaque para alguns artigos chave deste capítulo.

Art. 8º - As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante **participação complementar da iniciativa privada**, serão organizados de forma **regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente**.

Art. 9º - A **direção** do Sistema Único de Saúde (SUS) é **única**, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:
I - no âmbito da **União**, pelo **Ministério da Saúde**;
II - no âmbito dos **Estados e do Distrito Federal**, pela respectiva **Secretaria de Saúde** ou órgão equivalente; e
III - no âmbito dos **Municípios**, pela respectiva **Secretaria de Saúde** ou órgão equivalente.

No artigo 8º ficam reiteradas a regionalização e hierarquização como princípios estruturantes para a organização do SUS. Essa necessidade de reafirmar estes princípios decorre da longa história de centralização do sistema de saúde em estruturas federais como principais prestadores de serviços de saúde aos trabalhadores que possuíam cobertura previdenciária.

Já no artigo 9º observa-se a inequívoca declaração de que o SUS deve ter comando único em cada instância, e identifica o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais como responsáveis por esse comando em suas respectivas esferas. Isso significa que seus representantes são a autoridade que determina os rumos das políticas de saúde em seus territórios.

AOCP – EBSERH/HU-UFJF – 2015

25) No âmbito dos municípios, o Sistema Único de Saúde (SUS) é dirigido

(A) pelo Ministério da Saúde.

(B) pela Secretaria Federal de Saúde.

(C) pela Secretaria Municipal de Saúde.

(D) pela Secretaria Estadual de Saúde ou órgão equivalente.

(E) pelos Hospitais Particulares com convênio com o SUS.

Comentário

Essa é uma questão um tanto tola, mas é importante que eu lhe apresente todos os tipos de questões que aparecem nas provas. Nunca torça por questões muito fáceis na prova, pois isso favorece os que menos se preparam. A resposta desta questão é letra C.

AOCP – EBSERH/HE-UFSCAR – 2015

22) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

(A) no âmbito da União, pelo Ministério da Previdência, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e, no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

(B) no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Desenvolvimento e

Cidadania ou órgão equivalente; e, no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
(C) no âmbito da União, pelo Fundo Nacional de Saúde, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
(D) no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e, no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
(E) no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e, no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Desenvolvimento e Cidadania ou órgão equivalente.

Comentário

Por mais criativos que tentem ser os formuladores de questões das bancas, não tem jeito, esse tema é muito fácil. A direção do SUS no âmbito federal é do Ministério da Saúde, no âmbito estadual das Secretarias Estaduais de Saúde e no âmbito municipal das Secretarias Municipais de Saúde. A resposta só pode ser a letra D.

Outro grupo importante de artigos que nos permite entender a organização do SUS está nas **Seções I e II do capítulo IV**, onde temos descrito as **atribuições comuns e competências de cada esfera de governo**. Preparei 2 quadros resumos em que no primeiro eu listo de maneira simplificada as principais atribuições que são comuns à todos. No segundo quadro esboço as competências específicas de cada esfera, que em geral são complementares. Por isso apresento em 3 colunas de uma mesma linha competências análogas ou complementares das 3 esferas, para que você possa compreender melhor. Perceba que em geral o

Ministério da Saúde possui atribuições mais relacionadas a **formulação e apoio a implementação de políticas**, as Secretarias Estaduais **coordenam a implementação das políticas junto aos municípios** e as Secretarias Municipais **executam as ações efetivamente**.

ATRIBUIÇÕES COMUNS

Definição de mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde;
Administração dos recursos orçamentários e financeiros
Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais;
Organização e coordenação do sistema de informação de saúde;
Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos
Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador;
Participação na formulação e execução das políticas de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente;
Elaboração e atualização periódica do plano de saúde;
Participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde;
Elaboração da proposta orçamentária conforme o plano de saúde;
Elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública;
Para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera correspondente poderá requisitar bens e serviços, sendo-lhes assegurada justa indenização;

Implementar o sistema nacional de sangue, componentes e derivados;
Propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente;
Elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde;
Promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde;
Promover a articulação da política e dos planos de saúde;
Realizar pesquisas e estudos na área de saúde;
Definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária;
Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial.

COMPETÊNCIAS DAS ESFERAS DE GESTÃO DO SUS

FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
Participar na formulação e na implementação das políticas: de controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; e relativas às condições e aos ambientes de trabalho	Participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico e das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho	Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho
Definir e coordenar os sistemas: de rede de laboratórios de saúde pública; de vigilância epidemiológica; e vigilância sanitária	Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços: de vigilância epidemiológica; de vigilância sanitária	Executar serviços De vigilância epidemiológica; vigilância sanitária;
Participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio	Participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente	Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana

ambiente		
Participar da definição de normas e coordenar a política de saúde do trabalhador	Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de saúde do trabalhador	Executar serviços de saúde do trabalhador
Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras	Colaborar com a união na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras	Colaborar com a união e os estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras
Formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde	Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde	Dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde
Prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios	Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde	Formar consórcios administrativos intermunicipais
Promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde	Promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde	Normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação
Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados	Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros	Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros
Acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais	Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional	Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde
Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;	Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de alimentação e nutrição	Executar serviços de alimentação e nutrição
Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos	Formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de qualidade para produtos	
Elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS		Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e

		hierarquizada, em articulação com sua direção estadual;
Promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde		
Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em		
Executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual SUS ou que representem risco de disseminação nacional.		

Este tópico é muito abrangente, envolve diferentes artigos da lei 8.080, por isso nos traz o maior número de questões agregadas. Vamos varrê-las!!!

AOCP – EBSERH/HDT-UFT – 2015

24) De acordo com as disposições da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica são atribuições:
(A) do Conselho da Saúde, assessorado pelo Ministério de Ciências e Tecnologia.
(B) do Ministério da Ciência e Tecnologia, assessorado pela Conferência Nacional de Saúde.

(C) do Ministério da Saúde, assessorado pelo Conselho Nacional de Saúde.
(D) do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.
(E) exclusivas do Município, assessorado pela Conferência Nacional de Saúde.

Comentário

Em uma das leis adicionais da 8.080, junto aquela longa lista de items acrescentados no artigo 19, encontramos o item Q que faz referência ao objeto desta questão. Mas para te mostrar que você não precisa decorar as mais de 20 páginas do corpo da lei inteiro, pense comigo. Quando a questão traz a ideia de alguma instância que tem poderes para incorporar, excluir ou alterar qualquer coisa pelo SUS, podemos supor 2 coisas.

A primeira é que só pode ser um representante do poder executiva, a segunda é que se ele generalizou o uso do termo SUS é porque se refere ao âmbito nacional. Juntando as 2 coisas ele só pode estar se referindo ao Ministério da Saúde. Isso só nos deixa as alternativas C e D.

Protocolos e diretrizes clínicas são produtos tecnicamente muito específicos, portanto demanda a participação de pessoas que entendam do assunto, assim uma Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS para ser o apoio adequado para o Ministério decidir sobre novos medicamentos, produtos e procedimentos. Portanto a resposta é D.

AOCP – EBSERH/HU-UFJF – 2015

24) Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos
(A) em regime de tempo integral.

(B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
(C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 (quarenta e oito) horas.
(D) sem ter horário determinado, por tratar-se de cargo de confiança.
(E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

Comentário

Esta e a próxima questão tratam de um aspecto específico, que é a gestão de pessoal. Não é difícil imaginar que a ocupação de cargos estratégicos na gestão do SUS demanda uma dedicação de regime integral. Confiram maiores detalhes sobre isto no artigo 28. A resposta é letra A.

IBFC – EBSERH/CHC-UFPR – 2015

24) Sobre a Lei Federal n° 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:
(A) A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
(B) Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
(C) Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
(D) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
(E) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esferea de governo.

Comentário

Essa questão se refere a um aspecto específico da organização do SUS que é o ordenamento da política de recursos humanos, constante no Título IV, que abrange os artigos de 27 à 30. Este título trata de questões ocupacionais e de formação profissional. Está previsto na lei a criação de programas permanentes de aperfeiçoamento, essa é uma necessidade quase óbvia.

Um dos artigos menciona ainda que a dedicação exclusiva ao SUS deve ser valorizada e não evitada. As carreiras da saúde possuem um prerrogativa diferenciada que permite que os profissionais atuem em mais de um estabelecimento e tenham uma jornada de trabalho maior do que de outras profissões, isso se dá devido a carência de profissionais para suprir os serviços.

A implementação destas diretrizes depende do envolvimento dos gestores em cada esfera de governo, e não apenas de uma esfera. Só nos resta optar então pela alternativa C, que refere que a política deve alcançar todos os níveis de ensino, inclusive a pós-graduação.

AOCP – EBSERH/HU-UFJF – 2015

24) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Sobre os serviços privados de assistência à saúde, é correto afirmar que:

(A) a assistência à saúde é proibida à iniciativa privada.

(B) na prestação de serviços privados de assistência à saúde serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.

(C) não é permitida a participação de capital estrangeiro na assistência à saúde.
(D) em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS).
(E) são proibidas as doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.

Comentário

A lei é categórica em afirmar que a iniciativa privada é livre para atuar no SUS, contanto que obedeça as regras estabelecidas pelas normativas emitidades pelo gestor responsável pelo território onde atua. A resposta a esta questão está na alternativa B. Já vimos nesta aula também que em legislação recente passou a ficar oficialmente permitido a participação de capital estrangeiro no SUS.

AOCP – EBSERH/HC-UFG – 2015

25) Quanto aos serviços privados de assistência à saúde, assinale a alternativa correta.
(A) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, não serão observadas as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde quanto às condições para seu funcionamento.
(B) Não é permitida, em nenhuma hipótese, a participação direta de capital estrangeiro na assistência à saúde.
(C) O Sistema Único de Saúde deverá sempre prover cobertura assistencial à população, não podendo recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
(D) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde, aprovados no Conselho Nacional de Saúde.

(E) Os administradores de entidades contratadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) podem exercer cargo de chefia no SUS.

Comentário

Eu trouxe mais uma sobre a participação da iniciativa privada no SUS. O artigo 26 da lei 8.080 esclarece que mesmo que a iniciativa privada seja livre para atuar, ela tem de basear-se no regramento do Ministério da Saúde quanto aos critérios de remuneração de serviços.

Quando se trata da contratação de empresas para ofertar serviços às Secretarias de Saúde (atuação complementar), temos a tabela SUS para referenciar esses preços. Já para a prática de venda de serviços direto a população (atuação suplementar), seja por meio particular ou plano de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece parâmetros para precificação. Portanto a Resposta correta é D.

Pref. Castelo/ES – COMAJ – 2007

22) Marque alternativa correta. A direção nacional do Sistema Único de Saúde SUS, compete definir e coordenar os sistemas:

A) De redes integradas de assistência de alta complexidade.

B) De rede de laboratórios de saúde pública.

C) De Vigilância Epidemiológica.

D) Vigilância sanitária.

E) Todas as alternativas estão corretas.

Comentário

Encerramos esse tópico com questões sobre competências dos entes federados e começamos por esta questão que aborda competência do Ministério da Saúde. Como eu disse durante a aula, basicamente as competências dos 3 níveis de governo é bem semelhante, só que cada um atua no âmbito de sua governabilidade.

Portanto se uma questão sobre isso tomar o cuidado de não trazer a exclusividade de só um ente federal (federal, estadual ou municipal),

terá grandes chances de ter suas alternativas corretas. Esse é o caso aqui. Pode assinalar na letra E.

AOCP – EBSERH/HU-UFJF – 2015

21) Conforme a Lei n.° 8.080, de 19 de Dezembro de 1990, à direção estadual do Sistema único de Saúde (SUS) compete

(A) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.

(B) coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa.

(C) participar do planejamento programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual.

(D) participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

(E) dar execução, no âmbito municipal, às política de insumos e equipamentos para a saúde.

Comentário

Estamos procurando nesta questão competências ou atribuições que sejam exclusivas do âmbito da gestão estadual. Segundo nossa tabela, e o entendimento que se pode ter ao ler todas as alternativas, vemos que as alternativas A, C, D e E referem-se a competências municipais. Portanto a resposta correta é a letra B.

Faço apenas uma ressalva de que em tese o Ministério da Saúde não deveria ser executor de ações finalísticas, apenas formulador e fomentador de políticas, mas pela história centralizadora do sistema de saúde brasileiro, o governo federal permaneceu com a gestão de alguns serviços assistenciais, o que na prática pode levá-lo a execução de ações análogas a esfera municipal. Realidade não muito diferente dos Estados.

Pref. Abelardo Luz/SC – CURSIVA – 2015

32) De acordo com Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, especificamente do capítulo que dispõe das competências e das atribuições de cada ente federado, cabe à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) executar serviços de, exceto:

A) de vigilância epidemiológica;

B) de controle das agressões ao meio ambiente;

C) de alimentação e nutrição;

D) de saneamento básico.

Comentário

Seguindo o mesmo raciocínio já referido antes, nesta questão é só você procurar quais são as competências que efetivamente são da saúde e qual não é. Não é tão relevante nesta questão distinguir o nível governamental. Nenhuma instância da saúde (federal, estadual ou municipal) cuidam do controle de agressões ao meio ambiente, por mais que isso afete a saúde humana. É para isso que serve o Ministério e as Secretarias de Meio Ambiente. Por isso a letra é B.

Pref. Abelardo Luz/SC – ICAP – 2011

15) O artigo 18 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, trata das competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde SUS. Dentre as competências da direção municipal, podemos citar:

I. Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde, em articulação com sua direção estadual.

II. Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano.

III. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
IV. Normatizar as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação mediante aprovação da direção estadual.
V. Colaborar com a União e com os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas:
a) I, II e IV.
b) I, III e IV.
c) I, III e V.
d) II, IV e V.
e) Todas estão corretas.

Comentário

Apenas 2 afirmativas destas estão incorretas. A primeira é a II pois descreve as competências da ANVISA (autarquia ligado ao Ministério da Saúde), cabe ao âmbito municipal ações mais executoras e não formulação de diretrizes. E a outra é a IV, pois a despeito de ser desejável um alinhamento dos municípios com as políticas estaduais, os entes federados são autônomos, assim os municípios não precisam ter aprovação estadual para criar suas normativas. Achei essa questão bem desafiante.

AOCP – EBSERH/HE-UFSCAR – 2015

22) Assinale a alternativa correta.
(A) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, a atribuição de propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente.
(B) Ao Sistema Único de Saúde, compete participar na formulação e na implementação das políticas de saneamento básico.

(C) A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, não abrangerá ciência e tecnologia.
(D) Não caberá à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em seu âmbito administrativo, a atribuição de elaborar as normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública.
(E) Não é princípio do Sistema Único de Saúde, a capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

Comentário

Reiteradas vezes nos quadros vimos a questão de participação da saúde na formulação e implementação de políticas de saneamento básico. Isso se relaciona inclusive com um princípio importante de construtução do SUS, a intersetorialidade. Com isso vemos que a alternativa correta aqui é a letra B. Porém observamos também que o texto da letra A confere perfeitamente ao que referi no quadro e o que encontramos no texto da lei. Então também está certa, o que levou a anulação da questão.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO SUS

O poder público estadual tem, então, como uma de suas responsabilidades nucleares, mediar a relação entre os sistemas municipais; o federal de mediar entre os sistemas estaduais.

As instâncias básicas para a viabilização desses propósitos integradores e harmonizadores são os fóruns de negociação, integrados pelos gestores **municipal, estadual e federal – a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) – e pelos gestores estadual e municipal – a Comissão Intergestores Bipartite (CIB)**. Por meio dessas instâncias e dos Conselhos de Saúde, são viabilizados os princípios de unicidade e de equidade.

As Comissões Intergestores Bipartite são **instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intraestaduais e a definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite**. As deliberações das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite devem ser por consenso.

Nas CIB e CIT são **apreciadas as composições dos sistemas municipais de saúde**, bem assim **pactuadas as programações entre gestores** e integradas entre as esferas de governo. Da mesma forma, **são pactuados os tetos financeiros possíveis** – dentro das disponibilidades orçamentárias conjunturais – oriundos dos recursos das três esferas de governo, capazes de viabilizar a atenção às necessidades assistenciais e às exigências ambientais.

A despeito do que as Normas Operacionais Básicas (NOB) já traziam a respeito do papel destas Comissões, por meio de portarias, fazia-se necessário regulamentar isso em outro nível. Veio então em 2011

com a promulgação da lei nº 12.466 a inclusão dos seguintes artigos à lei 8.080:

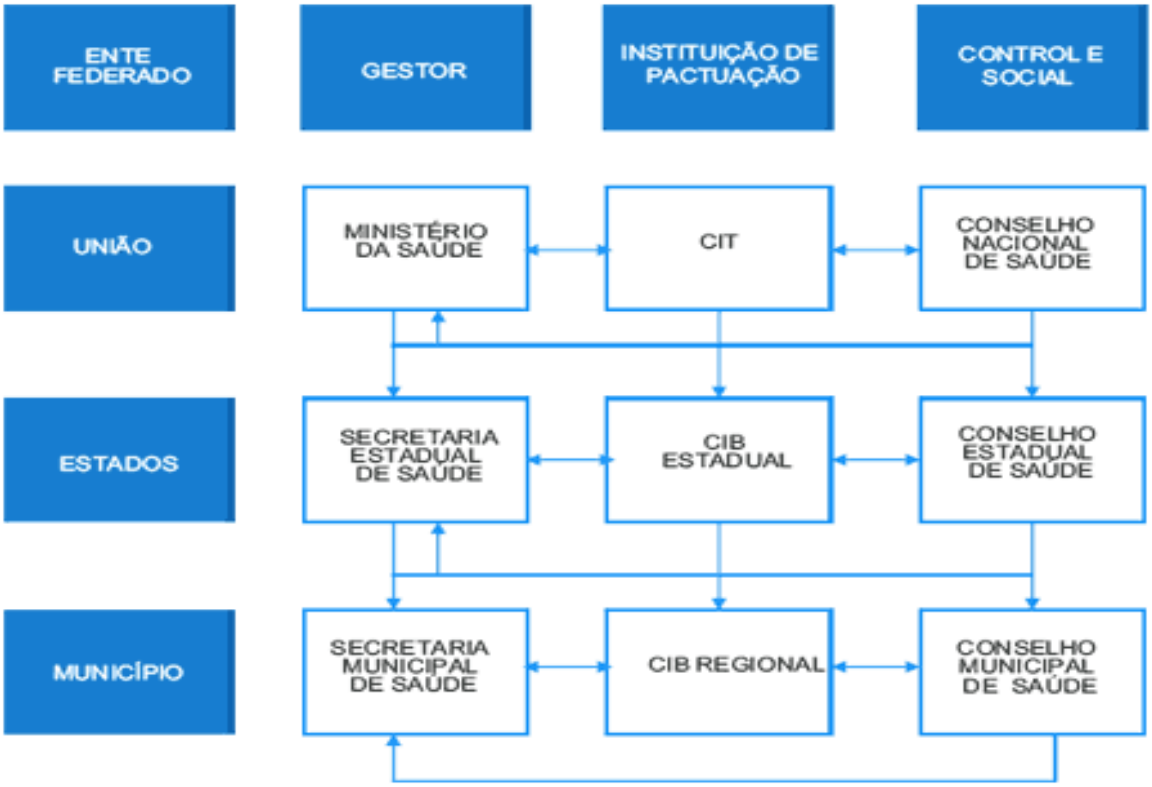
Art.14-A. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).
Parágrafo único. A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo:
I - decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde;
II - definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados;
III - fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados.

A **CIT** é composta, paritariamente, por representação do Ministério da Saúde (MS), do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). Já a **CIB**, composta igualmente de forma paritária, é integrada por representação da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) ou órgão equivalente. Um dos representantes dos municípios é o Secretário de Saúde da Capital. A Bipartite pode operar por meio Comissões Intergestores Regionais (CIR), sobre as quais discutiremos melhor na

última aula. Vejamos no artigo seguinte qual a definição de cada uma dessas instâncias.

Art. 14-B. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento.
§ 1º - O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União.
§ 2º - Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao Conasems, na forma que dispuserem seus estatutos.

Segue abaixo um esquema para ajudá-lo(a) a fixar melhor esta correlação entre os órgãos executivos, as Comissões e os Conselhos.



Eis nossa questão derradeira para fecharmos esta aula!

AOCP – EBSERH/Nacional – 2015

22) Assinale a alternativa correta.

(A) A direção do Sistema Único de Saúde é descentralizada, sendo exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos Estados e Distrito Federal, pela respectiva Secretaria ou órgão equivalente e, no âmbito dos municípios, pelas respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, sendo que estes não podem se unir, por meio de consórcio ou qualquer outro meio, para desenvolver em conjunto suas ações.

(B) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde.

(C) A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, não abrangerá ciência e tecnologia.

(D) Não caberá à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em seu âmbito administrativo, a atribuição de elaborar as normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública.
(E) Não é princípio do Sistema Único de Saúde a capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

Comentário

A alternativa A faz uma descrição correta de quais orgãos exercem a direção do SUS em cada esfera de poder, mas ao final nega a possibilidade de uso de um dispositivo importante e garantido nos artigos 10 e 18 da lei 8.080, a formação de consórcios municipais. A alternativa B apresenta corretamente a CIB e a CIT como instâncias criadas para pactuação entre gestores do SUS, é portanto a resposta a ser assinalada.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. **A Gestão do SUS** – Brasília: CONASS, 2015. 133 p.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. **Legislação Estruturante do SUS** / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2011. 534 p. (Coleção Para entender a gestão do SUS 2011, 13)

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância à Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Diretrizes Nacionais da Vigilância em Saúde** – Brasília : Ministério da Saúde, 2010.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. **Sistema de Planejamento do SUS: uma**

construção coletiva: organização e funcionamento – 3. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 100 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Cadernos de Planejamentov. 1)

Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. **Para entender a gestão do SUS** / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. - Brasília: CONASS, 2003. 248 p.



QUESTÕES



AOCP – EBSERH/HDT-UFT – 2015

1) De acordo com as definições trazidas pela Lei Orgânica da Saúde - Lei n° 8.080/1990, a Vigilância Epidemiológica:

(A) está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde e é definida como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

(B) está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde e é definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de

recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

(C) está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde e é definida como o controle exercido sobre todos os bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

(D) não está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde e é definida como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

(E) não está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde e é definida como o controle exercido sobre todos os bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

AOCP – EBSERH/HU-UFJF – 2015

2) Conforme a Lei n.° 8.080, de 19 de Dezembro de 1990, à direção estadual do Sistema único de Saúde (SUS) compete

(A) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.

(B) coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa.

(C) participar do planejamento programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual.

(D) participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

(E) dar execução, no âmbito municipal, às política de insumos e equipamentos para a saúde.

IBFC – EBSERH – 2013

3) A lei 8080/90 não inclui entre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde:

(A) Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.

(B) Utilização da estratificação de risco como estratégia para a Atenção de Urgência e Emergência.

(C) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.

(D) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

IBFC – EBSERH/CHC-UFPR – 2015

4) Sobre a Lei Federal n° 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

(A) A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.

(B) Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

(C) Inclui-se nos objetivos da política de recuros humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.

(D) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

(E) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esferea de governo.

IBFC – EBSERH/HU-UNIVASF – 2014

5) Um dos princípios do Sistema Único de Saúde, definido pela lei 8080/90 é:

(A) Ambiência.

(B) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.

(C) Não maleficência.

(D) Humanização da assistência em todos os seus níveis.

(E) Centralização político-administrativa.

IBFC – EBSERH – 2013

6) A lei 8080/1990 NÃO incluiu no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS:

(A) A participação na formulação da política e na execução de ações de combate à fome e distribuição de renda.

(B) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

(C) A vigilância nutricional e orientação alimentar.

(D) A colaboração na proteção do meio ambiente.

IBFC – EBSERH/HU-UNIVASF – 2014

7) A lei 8080/90 definiu princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Não consta entre esses princípios e diretrizes:

(A) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

(B) Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.

(C) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.

(D) Acolhimento ao usuário, com ênfase na estratificação de risco.

(E) Igualmente da assistência à saúde.

AOCP – EBSERH/HC-UFG – 2015

8) Quanto aos serviços privados de assistência à saúde, assinale a alternativa correta.

(A) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, não serão observadas as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde quanto às condições para seu funcionamento.

(B) Não é permitida, em nenhuma hipótese, a participação direta de capital estrangeiro na assistência à saúde.

(C) O Sistema Único de Saúde deverá sempre prover cobertura assistencial à população, não podendo recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

(D) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde, aprovados no Conselho Nacional de Saúde.

(E) Os administradores de entidades contratadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) podem exercer cargo de chefia no SUS.

AOCP – EBSERH/Nacional – 2015

9) Assinale a alternativa correta.

(A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde, nos primeiros níveis de assistência, é um dos princípios do Sistema Único de Saúde.

(B) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é dividida e descentralizada, sendo exercida a direção em cada esfera de governo.

(C) Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.

(D) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde não poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

(E) É princípio do Sistema Único de Saúde a organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos.

AOCP – EBSERH/HE-UFSCAR – 2015

10) Assinale a alternativa correta.

(A) A saúde é um direito fundamental do ser humano e é um dever do Estado, não sendo responsabilidade da própria pessoa, da família, das empresas e da sociedade.

(B) A vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde.

(C) Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde: a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

(D) São campos de atuação do Sistema Único de Saúde, a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

(E) São princípios do Sistema Único de Saúde: a capacidade de resolução dos serviços, em todos os níveis de assistência e organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos.

IBFC – EBSERH-HU/UFMA – 2013

11) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi durante criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

(A) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque toma a vacinação demorada e com risco de menos cobertura.

(B) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.

(C) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.

(D) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.

(E) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

AOCP – EBSERH/HC-UFG – 2015

12) Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

(A) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

(B) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

(C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

(D) Participação da comunidade.

(E) O atendimento prioritário aos pobres, das crianças e mulheres.

IBFC – EBSERH-HU/UFMA – 2013

13) Considerando os determinantes sociais de saúde, assinale a alternativa incorreta:

(A) As redes sociais ou comunitárias, expressas pelo nível de coesão soial têm pouca importância para a saúde da sociedade como um todo.

(B) Características individuais de idade, gênero e fatores genéticos exercem influência sobre seu potecial e suas condições de saúde.

(C) Educaçcao e habitação são determinantes fundamentais de saúde.

(D) Trabalho e desemprego são determinantes fundamentais de saúde.

(E) A produção agrícola de alimentos é um determinante social de saúde.

IBFC – EBSERH/HU-UNIVASF – 2014

14) Considerando os determinantes de saúde, não pode ser considerado um determinante social de saúde:

(A) Produção agrícola de alimentos.
(B) Educação.
(C) Ambiente de trabalho.
(D) Habitação.
(E) Idade.

IBFC – EBSERH-HU/UFMA – 2013

15) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:
(A) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
(B) Há associação entre estilos de vida sedentários e maior prevalência de hipertensão arterial.
(C) Há associação entre atividad profissional e prevalência de hipertensão.
(D) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
(E) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturados e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

AOCP - EBSERH/HC-UFG – 2015

16) Assinale a alternativa correta.
(A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso preferencial aos mais pobres às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(B) O dever do Estado de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
(C) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
(D) As fundações mantidas pelo Poder Público e a Administração Pública Indireta não fazem parte do Sistema Único de Saúde.
(E) A iniciativa privada deverá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter complementar.

AOCP – EBSERH/Nacional – 2015

17) Assinale a alternativa correta.
(A) A direção do Sistema Único de Saúde é descentralizada, sendo exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos Estados e Distrito Federal, pela respectiva Secretaria ou órgão equivalente e, no âmbito dos municípios, pelas respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, sendo que estes não podem se unir, por meio de consórcio ou qualquer outro meio, para desenvolver em conjunto suas ações.
(B) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde.
(C) A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, não abrangerá ciência e tecnologia.
(D) Não caberá à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em seu âmbito administrativo, a atribuição de elaborar as normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública.

(E) Não é princípio do Sistema Único de Saúde a capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

IBFC – EBSERH/HU-UFMA – 2013

18) Dois municípios vizinhos se associaram com o abjetivo de melhorar a atenção à saúde. Decidiu-se que caberia ao município A a realização de mamografia, quando indicada para as pacientes de ambas as localidades. O município B seria o responsável pela realização de exame de prevenção do câncer prostático em homens (clínico e dosagem de PSA - Antígeno Prostático Específico). Em sua opinião:

(A) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS.

(B) A medida está incorreta pois compromete o princípio da integralidade do SUS.

(C) A medida fere o princípio da divulgação de informações quanto ao potecial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.

(D) A medida está de acordo com o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

(E) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

AOCP – EBSERH/HE-UFSCAR – 2015

19) Assinale a alternativa correta.

(A) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, a atribuição de propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente.

(B) Ao Sistema Único de Saúde, compete participar na formulação e na implementação das políticas de saneamento básico.

(C) A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, não abrangerá ciência e tecnologia.

(D) Não caberá à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em seu âmbito administrativo, a atribuição de elaborar as normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública.
(E) Não é princípio do Sistema Único de Saúde, a capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

AOCP – EBSERH/HE-UFSCAR – 2015

20) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:
(A) no âmbito da União, pelo Ministério da Previdência, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e, no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
(B) no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Desenvolvimento e Cidadania ou órgão equivalente; e, no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
(C) no âmbito da União, pelo Fundo Nacional de Saúde, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
(D) no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e, no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
(E) no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente e, no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Desenvolvimento e Cidadania ou órgão equivalente.

AOCP – EBSERH/HC-UFG – 2015

21) Assinale a alternativa correta.

(A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

(B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.

(C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

(D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.

(E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

AOCP – EBSERH/HC-UFG – 2015

22) Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

(A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.

(B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

(C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.

(D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

(E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

AOCP – EBSERH/HU-UFJF – 2015

23) Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos

(A) em regime de tempo integral.

(B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.

(C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 (quarenta e oito) horas.

(D) sem ter horário determinado, por tratar-se de cargo de confiança.

(E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

AOCP – EBSERH/HDT-UFT – 2015

24) De acordo com as disposições da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica são atribuições:

(A) do Conselho da Saúde, assessorado pelo Ministério de Ciências e Tecnologia.

(B) do Ministério da Ciência e Tecnologia, assessorado pela Conferência Nacional de Saúde.

(C) do Ministério da Saúde, assessorado pelo Conselho Nacional de Saúde.

(D) do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.

(E) exclusivas do Município, assessorado pela Conferência Nacional de Saúde.

AOCP – EBSERH/HU-UFJF – 2015

25) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente

habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Sobre os serviços privados de assistência à saúde, é correto afirmar que:

(A) a assistência à saúde é proibida à iniciativa privada.

(B) na prestação de serviços privados de assistência à saúde serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.

(C) não é permitida a participação de capital estrangeiro na assistência à saúde.

(D) em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS).

(E) são proibidas as doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.

AOCP – EBSERH/HU-UFJF – 2015

26) No âmbito dos municípios, o Sistema Único de Saúde (SUS) é dirigido

(A) pelo Ministério da Saúde.

(B) pela Secretaria Federal de Saúde.

(C) pela Secretaria Municipal de Saúde.

(D) pela Secretaria Estadual de Saúde ou órgão equivalente.

(E) pelos Hospitais Particulares com convênio com o SUS.

Pref. Abelardo Luz/SC – ICAP – 2011

27) Dentre os objetivos do Sistema Único de Saúde SUS estão a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, e a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, conforme identifica o Artigo 5 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990. Para cumprir estes objetivos, o

Sistema Único de Saúde promove a execução de ações, por exemplo, através dos departamentos de:

I. Vigilância Sanitária.

II. Vigilância Epidemiológica.

III. Vigilância Ambiental em Saúde.

Relacione abaixo as ações exercidas por cada um dos departamentos citados acima:

( ) Conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde.

( ) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

( ) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Assinale a alternativa que contém a associação correta das colunas acima:

a) I, II, III.

b) I, III, II.

c) II, III, I.

d) III, II, I.

e) III, I, II.

Pref. Abelardo Luz/SC – CURSIVA – 2015

28) De acordo com Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, especificamente do capítulo que dispõe das competências e das

atribuições de cada ente federado, cabe à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) executar serviços de, exceto:

A) de vigilância epidemiológica;

B) de controle das agressões ao meio ambiente;

C) de alimentação e nutrição;

D) de saneamento básico.

Pref. Castelo/ES – COMAJ – 2007

29) De acordo com a Lei nº 8080/90, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores, submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, exceto:

A) Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.

B) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde - SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.

C) O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

D) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde - SUS, da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, produtos, máquinas e equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador.

E) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.

Pref. Castelo/ES – COMAJ – 2007

30) Marque alternativa correta. A direção nacional do Sistema Único de Saúde SUS, compete definir e coordenar os sistemas:

A) De redes integradas de assistência de alta complexidade.
B) De rede de laboratórios de saúde pública.
C) De Vigilância Epidemiológica.
D) Vigilância sanitária.
E) Todas as alternativas estão corretas.

Pref. Castelo/ES – COMAJ – 2007

31) De acordo com a Lei nº 8080/90, estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde SUS a execução de ações. Marque a alternativa correta:
A) De vigilância sanitária.
B) De vigilância epidemiológica.
C) De saúde do trabalhador.
D) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
E) Todas as alternativas estão corretas.

IBFC – SEPLAG/FUNED/MG – 2014

32) A Atenção à Saúde deve levar em conta as necessidades específicas de pessoas ou grupo de pessoas ainda que minoritários; ou seja, a cada qual de acordo com suas necessidades, inclusive no que é pertinente aos níveis de complexidade diferenciados. Essas premissas se referem a um dos princípio do Sistema Único de Saúde SUS, que é a:
A) Universalidade.
B) Integralidade.
C) Igualdade da assistência à saúde.
D) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.

SESAP/RN – CONSULPLAN – 2008

33) A partir da promulgação da nova Carta Constitucional em outubro de

1988, iniciou-se o processo de elaboração da Lei Orgânica de Saúde (LOS) - Lei 8080/1990, sancionada com vetos pelo Presidente da República. Sobre este assunto, nas alternativas abaixo marque V para as verdadeiras e F para as falsas:

( ) A LOS integrou os principais aspectos já consagrados na Constituição - saúde como direito do cidadão e dever do Estado.

( ) Promover também à LOS a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) com seus princípios de universalidade, equidade e integralidade das ações.

( ) Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo, destacando a municipalização, que também foi prevista pela LOS.

( ) A LOS ampliou o conceito de saúde incluindo sua caracterização social.

A sequência está correta em:

A) V,V,V,V.

B) V,V,V,F.

C) F,F,F,F.

D) V,F,F,V.

E) V,V,F,F.

SESAP/RN – CONSULPLAN – 2008

34) A Lei Federal nº 8080/1990 em seu artigo 6º determina a inclusão no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução das ações de vigilância, EXCETO:

A) Vigilância Sanitária das cozinhas industriais de restautantes.

B) Vigilância à Saúde do Trabalho

C) Vigilância ao trabalho escravo em fazendas.

D) Vigilância Epidemiológica.

E) Vigilância à assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

Pref. Abelardo Luz/SC – ICAP – 2011

35) O artigo 18 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, trata das competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde SUS. Dentre as competências da direção municipal, podemos citar:

I. Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde, em articulação com sua direção estadual.

II. Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano.

III. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.

IV. Normatizar as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação mediante aprovação da direção estadual.

V. Colaborar com a União e com os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas:

A) I, II e IV.

B) I, III e IV.

C) I, III e V.

D) II, IV e V.

E) Todas estão corretas.



Questão	Resposta	Questão	Resposta
1	B	19	A e B
2	B	20	D
3	B	21	A
4	C	22	A
5	B	23	A
6	A	24	D
7	D	25	B
8	D	26	C
9	E	27	D
10	C e E	28	B
11	B	29	C
12	E	30	E
13	A	31	E
14	E	32	B
15	A	33	A
16	C	34	C e E
17	B	35	C
18	D		

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.